

発達生理、新生児移行、小児悪化

年齢で変わる生理

在胎週数、日齢、成長、思春期

乳児の予備能は小さい

高い酸素需要、狭い気道
一回拍出量適応とグリコーゲンが限定

低血圧前から推移を重視

体温、血糖、ビリルビン

体温管理は代謝的介入

蒸発、伝導、対流、放射
褐色脂肪は低酸素とアシドーシスを悪化

血糖は供給、貯蔵、インスリン、需要を反映
反復なら内分泌・代謝原因

短い赤血球寿命が産生を増やす

腸管脱抱合が再吸収を促す
アルブミン結合で脳へ移りにくい

抱合型上昇は肝胆道疾患を示す

哺乳、成長、発達

哺乳は心肺・神経の協調課題

吸啜・嚥下・呼吸協調
報告時間でなく授乳を観察

体重とナトリウムで移送不足を捉える

体重は速く、身長は長期、頭囲は脳

出生後のパーセンタイル横断は正常あり
持続減速は評価を要する

到達項目は確率分布

技能喪失は遅い獲得より懸念

頻脈と血管収縮で血圧を保つ

早期ショック：斑状皮膚、再充満遅延

循環、輸液、脱水

体重換算で再評価する小分け輸液

改善不良で肝腫大・ラ音増加
心機能・昇圧支援を再考

原因固有の液体戦略

経口補水はナトリウム・グルコース共輸送

脳を守るためナトリウムを制御補正

安全保護と最終評価

外傷は発達能力に適合すべき

出血、骨、代謝性模倣を考える

発言をそのまま分けて記録

面談前に守秘の限界を説明

いつもと違うは縦断データ

追跡者を含む閉じた安全計画

出生時移行と蘇生

最初の呼吸が肺液を空気へ置換

肺血管抵抗が低下

胎盤除去で体血管抵抗上昇

卵円孔閉鎖、動脈管血流逆転

酸素とプロスタグランジン低下で収縮

含気不全・低酸素で胎児性短絡が残る

重症チアノーゼ

新生児蘇生の中心は呼吸

徐脈は含気不足と低酸素に続く
胸郭挙上と心拍上昇で換気確認
先にマスク密閉、頭位、圧を修正
胸骨圧迫は重度徐脈持続時のみ

蘇生後も血糖、体温、発作を監視

酸素は過不足双方が有害

動脈管依存性心疾患

動脈管閉鎖時に初めて現れる

肺血流依存：チアノーゼ悪化

体血流依存：ショック、大腿脈弱化

原因不明ショックは心疾患も考える

プロスタグランジンE1で動脈管再開

無呼吸・低血圧に気道能力を備える

呼吸悪化と気道

代償：呼吸数、陥没、呻吟

吸啜が呼吸と競合

疲労で呼吸数と努力が減る

静かな児はより危険

飽和度で換気は判断できない

二酸化炭素と臨床で評価

数値一つでなく仕事量で移行を決定

わずかな腫脹で抵抗が大きく増す

流涎、三脚位、含み声：声門上救急

咽頭診察が閉塞を誘発し得る

正常画像でも異物誤嚥を疑う

発熱と処方安全

若い乳児は哺乳不良だけのことも

危険徴候は全年齢で緊急評価

解熱薬はウイルスと細菌を区別しない

独立計算連鎖

先頭ゼロを使い末尾ゼロを避ける

肝酵素と糸球体濾過は別速度で成熟

一新生児週の適量が後に誤りに

高危険薬は三者が独立確認

キログラムとポンド、日量と一回量

保護者が注射器で実際の容量を示す